介護SCRの概説と利用上の留意点

令和８年６月

I.　本資料の位置づけについて

本資料は、介護保険総合データベース（以下「介護 DB」という。）を用いて作成した介護 SCR（Standardized Claim Ratio）と将来推計のデータセットを活用するうえで、基本的事項の概説と留意点について整理したものである。介護 SCR は、介護サービス提供量の地域差を調べるための指標であり、また将来推計は、各地域における需要の変化率を把握するためのものである。なお、介護保険事業計画や医療・介護連携に関する議論においては、医療 SCR（内閣府ホームページ（https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/chiikisa）で公開。以下同じ。）もあわせて参照されたい。

II.　地域、人口データ及びサービス区分について

（１）地域の設定

介護 SCR は、都道府県、二次医療圏（2025 年６月時点）、老人福祉圏域（2025 年６月時点）、市町村（特別区を含む。以下同じ。）の４区分で算出した。なお、各市町村の個別の取扱いは、「匿名介護保険等関連情報データベースの利用に関するガイドライン（第３版）」およびデータソースの集計仕様に準拠した。詳細は別添１の表脚注を参照されたい。

（２）使用した人口データ

介護 SCR の算出に用いる人口データは、住民基本台帳人口（各年１月時点）である。例えば、2023 年度介護 SCR の算出においては、2024 年１月時点の住民基本台帳人口を使用している。また、将来推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023 年推計）」を用いた。

（３）サービス提供量の指標と区分設定の考え方

サービス提供量の指標としては、介護 DB に収載されているレセプトコード出現数（レセプト件数）を用いた。サービス区分については、６桁のサービス種類コードに基づき、独自に設定した７つの区分により構成している（参照：下記サービス区分表）。サービス区分の策定にあたっては、複数の自治体担当者へのヒアリングを実施した。その結果、自治体の人口規模や集計目的によっては、上２桁のコード（例：11=訪問介護、12=訪問入浴介護など）よりも詳細な粒度での把握が必要とのニーズが確認された。本区分は、こうした現場の要望に対応すべく、厚生労働省老健局との協議を経て設計したものである。

○サービス区分表（詳細は別添２～４を参照）
【大区分】制度設計やサービスの基本特性による区分
区分１　　介護給付と予防給付
区分２－１　居宅系サービスと施設系サービス
区分２－２　居宅系サービスの中で居住系サービスを施設サービスと同じ区分と分類
区分２－３　提供形態（訪問、通所など）とサービス特性（多機能など）による分類
【中区分】サービス種別と提供内容による区分
区分３　　基本的なサービス種別と提供内容による分類
【細区分】サービス種別と提供内容、事業所、職種などによる区分
区分４－１　事業所種別や規模、提供職種、地域密着型との別を考慮した大まかな分類
区分４－２　事業所種別や規模、提供職種、地域密着型との別を考慮した分類

III. 介護 SCR について

（１）基本的な考え方

介護 SCR とは、当該地域の人口構成が全国と同じであると仮定した場合に、予測されるレセプトコード出現数（期待値）に対して、実際の出現数（実測値）がどの程度乖離しているかを、全国平均を「100」として算出した指標である。公式は以下のとおりである（年齢は原則５歳階級）。

$$SCR = \frac{\sum 性・年齢別レセプトコード出現数}{\sum(性・年齢別人口 \times 全国の性・年齢別レセプトコード出現率)} \times 100$$

本指標が 100 を上回れば、当該介護サービスの提供量が全国の平均的な水準よりも多いことを意味し、100 を下回れば少ないことを意味する。

（２）本指標の特徴

介護 SCR は、利用者住所地ベースでの集計を基本としている。これは、介護保険事業計画が被保険者（利用者）の住所地を基準として策定されるためである。一方で、地域の提供体制や資源の偏在を把握する観点から、事業所所在地ベースでの集計も併せて実施している。これら２つの視点を組み合わせることで、当該地域におけるサービスの需要（利用者側）と供給（事業所側）の双方の実態把握に活用されたい。

介護 SCR では、人口規模および性･年齢構成の影響が統計学的に補正されている。したがって、算出された地域差は、これら以外の要因（地域の提供体制やケアの傾向など）によるものと解釈できる。例えば、従来用いられてきた「受給率（一定期間の受給者数を第１号被保険者数で除した値）」を用いて地域差を比較する場合、人口規模は考慮できても、高齢化率などの人口構成の差異や、受給者１人あたりの利用量の違いまでは反映されず、提供量の多寡を解釈することは困難であった。これに対し、介護 SCR は、利用者数の多寡を示す指標ではなく、人口および人口構造の差異では説明しきれないサービス提供量の地域差を可視化する指標として有用である。

なお、地域間のサービス提供量を純粋に比較する観点から、本集計ではサービス種類コードに含まれる加算・減算に係るコードを除外している。また、集計対象には第１号及び第２号被保険者の双方を含めている。

ただし、一部のコードには、ケアの所要時間や人員の要件の組み合わせが含まれている。例えば、訪問介護の 11-1111「人員 1 人で 20 分以上 30 分未満」と 11-1221「人員 2 人で 30 分以上 1 時間未満」などが当てはまるが、この場合、いずれも区分 4-2 の「訪問介護（身体介護が中心）」のレセプト出現数１件としてカウントされ、所要時間や人員の多寡は考慮されていない点に留意されたい。

Ⅳ. 将来推計について

（１）基本的な考え方

将来推計は、将来推計人口および性･年齢構成の変化に対し、足元のサービス提供状況を投影している。将来需要の水準は、2025 年の推計人口に期待されるレセプトコード出現数を「100」として算出している。公式は以下のとおりである（年齢は原則５歳階級）。

$$推計値 = \frac{\sum(各推計年の性・年齢別推計人口 \times 2023\ 年の性・年齢別レセプトコード出現率)}{\sum(2025\ 年の性・年齢別推計人口 \times 2023\ 年の性・年齢別レセプトコード出現率)} \times 100$$

2030 年以降の数値が 100 を上回れば、当該地域のサービス需要が 2025 年時点よりも増加することを意味し、100 を下回れば減少することを意味する。ここで、性・年齢階級別の出現率は 2023 年度の実績値で据え置き、2025 年以降の各推計年の人口推計値を乗じることで算出している点に留意されたい。これは、将来の需要変化のうち、純粋に人口構造の推移に起因する影響を抽出することを目的とした設定である。なお、将来推計は指標の性質上、利用者住所地ベースのみで作成している。

本指標は需要の増加のみならず、ピークアウト後の減少時期やその減少速度に着目し、将来の資源配置を検討する際の基礎資料として活用されることを想定している。そのため、推計期間は 2050 年までとしている。

（２）本指標の特徴

将来推計で示された数値は、介護 SCR と目的も意味も全く異なる点に留意されたい。介護 SCR が、同一年度内における地域間の比較を目的とするものに対し、本指標は、あくまで各地域の人口

と人口構造の変化に伴う「増減の勢い（伸び率）」を把握するためのものであり、地域間の絶対的な多寡を示すものではない。

例えば、2040 年の値が「160」である場合、性・年齢層別のサービス利用状況が現状のまま継続すると仮定すると、2025 年を基準として 2040 年には需要が約 1.60 倍に増加することを示している。一方で、2040 年において、A市の推計値が 160 でB市が 120 であった場合、それは「A市の増加の勢いがB市より強い」ことを意味するに留まる。この数値をもって「A市の提供量がB市より多くなる」と判断することはできない。あくまで各地域の 2025 年時点を 100 とした際の「変化の度合い」を示している。

本指標は、各地域の政策的動向（例：療養病床の転換、地域密着型サービスの重点整備など）を反映したものではない。また、便宜上「需要」という表現を用いているが、これは足元のサービス提供状況が最適であることを前提としたものではなく、潜在的なニーズや提供内容の偏りも加味されていない。

したがって、本指標はあくまで現状の延長線上にある「参照値（ベースライン）」として捉えるべきである。各地域の今後の施策の必要性や介入効果を検討するための比較対照として活用されたい。

V. その他の留意点について

（1）単年度集計の数値変動に関する留意点

介護 SCR は、各年度の実績に基づく単年度集計である。そのため、被保険者数の少ない市町村や利用者が限定的なサービス区分においては、年度ごとの数値に変動（振れ幅）が生じやすい特性がある。介護 SCR のデータセットには、2023 年度だけでなく 2021・2022 年度の数値も併記した。数値を読み取る際は、単年度の数値のみで判断せず、3か年の推移を確認した上で、分析目的に応じた適切なサービス区分の粒度を選択することが重要である。

（2）事業所所在地ベースの集計に関する留意点

事業所所在地ベースの集計は、介護 DB の事業所台帳に付与された事業所所在地市町村番号に基づいている。集計結果を用いる際には、実際の所在地とは異なる市町村でカウントされるケースが一部で確認されている点に留意されたい。

（3）将来推計の 2030 年以降の数値の変動に関する留意点

将来推計は、介護 SCR（全国平均を参照）とは異なり、当該市町村自身のレセプトコード出現率をベースに算出している。そのため、分母（人口）が小さい場合には、介護 SCR 以上に数値の振れ幅が大きくなる可能性がある。このため、数値を読み取る際は、細かい粒度のサービス区分のみで判断せず、分析目的に応じた適切なサービス区分の粒度を選択されたい。

また、将来推計の推移において、2025 年（100）から一旦大きく低下した後、再び上昇しピークアウトするような挙動を示すケースが確認されている。このような場合や、2025 年時点ですでに将来推計人口と実際人口に乖離が生じている場合は、その影響を鑑みて数値を解釈する必要がある。

（4）医療 SCR との比較に関する留意点

医療 SCR は「医療機関所在地ベース」で集計される指標である。一方、介護 SCR は、前述のとおり、「利用者住所地ベース」での集計を基本としており、両者の算出基準が異なる点に留意されたい。

また、医療 SCR の解釈にあたっては、近隣自治体間での流出入（境界を越えた受診）の影響を受ける。そのため、市町村単位の数値のみでなく、二次医療圏などの広域単位での値を参照することも、地域の実態を正確に把握する上で有効なアプローチである。

別添1

○データファイルの構造

ファイル名	地域※	参照人口	参照レセプト	基準	サービス区分数	地域数	行数
SCRPACKRMED2021_2023	全国	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	1	227
	└都道府県	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	47	10,669
	└二次医療圏	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	329	74,683
	└市区町村	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	1,741	395,207
SCRPACKRWEL2021_2023	全国	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	1	227
	└都道府県	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	47	10,669
	└老人福祉圏域	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	336	76,272
	└市区町村	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	1,741	395,207
xSCRPACKRMED2021_2023	全国	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	1	227
	└都道府県	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	47	10,669
	└二次医療圏	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	329	74,683
	└市区町村	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	1,741	395,207
xSCRPACKRWEL2021_2023	全国	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	1	227
	└都道府県	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	47	10,669
	└老人福祉圏域	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	336	76,272
	└市区町村	2022～2024（各年1月）	2021～2023（各年度）	全国・サービス区分別	227	1,741	395,207
SCRPACKRMEDPRED2025_2050	全国	2025～2050（5年刻み各年10月）	2023年度	全国・サービス区分別	227	1	227
	└都道府県	2025～2050（5年刻み各年10月）	2023年度	全国・サービス区分別	227	47	10,669
	└二次医療圏	2025～2050（5年刻み各年10月）	2023年度	全国・サービス区分別	227	329	74,456
	└市区町村	2025～2050（5年刻み各年10月）	2023年度	全国・サービス区分別	227	1,730	392,710
SCRPACKRWELPRED2025_2050	全国	2025～2050（5年刻み各年10月）	2023年度	全国・サービス区分別	227	1	227
	└都道府県	2025～2050（5年刻み各年10月）	2023年度	全国・サービス区分別	227	47	10,669
	└老人福祉圏域	2025～2050（5年刻み各年10月）	2023年度	全国・サービス区分別	227	336	76,045
	└市区町村	2025～2050（5年刻み各年10月）	2023年度	全国・サービス区分別	227	1,730	392,710

※1「匿名介護保険等関連情報データベース（介護保険総合データベース、介護DB）の利用に関するガイドライン（第3版）」に基づき、政令指定都市20市（札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市）は、行政区単位ではなく市単位で集計した。また、二次医療圏の「川崎北部」と「川崎南部」は、老人福祉圏域の「川崎」と一致させた。

※2人口推計において、福島県のいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の13市町村は「浜通り地域」として推計されているため、人口推計の市町村は、「浜通り地域」とした。

※3人口推計において、「浜通り地域」は、二次医療圏「相双」と「いわき」、老人福祉圏域「相双」と「いわき」を合わせた地域であるため、「相双」と「いわき」は、「浜通り地域」として集計した。

厚生労働科学研究費補助金〈長寿科学政策研究〉「2040年を見据えた地域特性に応じた介護サービス提供体制の最適化と科学的介護の推進に関する調査研究」（研究代表者：陣内裕成）

別添2

○介護 SCR におけるサービス区分（介護給付）

区分 1	区分 2-1	区分 2-2	区分 2-3	区分 3	区分 4-1	区分 4-2
介護給付系	居宅系	居宅系	訪問系	訪問介護	訪問介護（身体介護が中心）	訪問介護（身体介護が中心）
					訪問介護（身体介護＋生活援助、通院等乗降介助）	訪問介護（身体介護＋生活援助）
						訪問介護（通院等乗降介助）
					訪問介護（生活援助が中心）	訪問介護（生活援助が中心）
				訪問入浴介護	訪問入浴介護（看護職員＋介護職員）	訪問入浴介護（全身浴・看護職員＋介護職員）
						訪問入浴介護（部分浴・看護職員＋介護職員）
					訪問入浴介護（介護職員のみ）	訪問入浴介護（全身浴・介護職員のみ）
						訪問入浴介護（部分浴・介護職員のみ）
				訪問看護	訪問看護（保健師・看護師）	訪問看護（指定訪問看護ステーション、保健師・看護師）
						訪問看護（病院・診療所、保健師・看護師）
					訪問看護（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）	訪問看護（指定訪問看護ステーション、理学・作業・言語聴覚士）
				訪問リハビリテーション	訪問リハビリテーション（病院・診療所）	訪問リハビリテーション（病院・診療所）
					訪問リハビリテーション（介護老人保健施設・介護医療院）	訪問リハビリテーション（介護老人保健施設）
						訪問リハビリテーション（介護医療院）
				居宅療養管理指導	居宅療養管理指導（医師）	居宅療養管理指導（医師）
					居宅療養管理指導（歯科医師）	居宅療養管理指導（歯科医師）
					居宅療養管理指導（管理栄養士）	居宅療養管理指導（管理栄養士）
					居宅療養管理指導（薬剤師）	居宅療養管理指導（薬剤師）
					居宅療養管理指導（歯科衛生士等）	居宅療養管理指導（歯科衛生士等）
				定期巡回・随時対応訪問介護看護	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	定期巡回・随時対応型訪問介護看護
					夜間対応型訪問介護	夜間対応型訪問介護
			通所系	通所介護	通所介護（認知症対応型を除く）	通所介護（通常規模型）
						通所介護（大規模型）
						地域密着型通所介護
						療養通所介護費・短期利用療養通所介護
					認知症対応型通所介護	認知症対応型通所介護（単独型）
						認知症対応型通所介護（併設型）
						認知症対応型通所介護（共用型）
				通所リハビリテーション	通所リハビリテーション（介護老人保健施設・介護医療院）	通所リハビリテーション（通常規模型、介護老人保健施設）
						通所リハビリテーション（大規模型、介護老人保健施設）
						通所リハビリテーション（通常規模型、介護医療院）
						通所リハビリテーション（大規模型、介護医療院）
					通所リハビリテーション（病院・診療所・介護医療院）	通所リハビリテーション（通常規模型、病院・診療所）
						通所リハビリテーション（大規模型、病院・診療所）

（次頁につづく）

厚生労働科学研究費補助金〈長寿科学政策研究〉「2040 年を見据えた地域特性に応じた介護サービス提供体制の最適化と科学的介護の推進に関する調査研究」（研究代表者：陣内裕成）

（続き）

区分 1	区分 2-1	区分 2-2	区分 2-3	区分 3	区分 4-1	区分 4-2
介護給付系	居宅系	居宅系	短期入所系	短期入所生活介護	短期入所生活介護	短期入所生活介護（単独型）
						短期入所生活介護（併設型）
				短期入所療養介護	短期入所療養介護（介護老人保健施設・介護医療院）	短期入所療養介護（介護老人保健施設）
						短期入所療養介護（介護医療院）
					短期入所療養介護（病院・診療所）	短期入所療養介護（療養病床を有する病院）
						短期入所療養介護（診療所）
		施設居住系	居住系	特定施設入居者生活介護	特定施設入居者生活介護	特定施設入居者生活介護（短期利用以外）
						特定施設入居者生活介護（短期利用）
					地域密着型特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用以外）
						地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用）
				認知症対応型共同生活介護	認知症対応型共同生活介護	認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）
						認知症対応型共同生活介護（短期利用）
		居宅系	多機能系	小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護（短期利用以外）
						小規模多機能型居宅介護（短期利用）
				看護小規模多機能型居宅介護	看護小規模多機能型居宅介護	看護小規模多機能型居宅介護（短期利用以外）
						看護小規模多機能型居宅介護（短期利用）
			住環境整備系	福祉用具貸与	福祉用具貸与	福祉用具貸与（用具別※詳細は別添 4 参照）
			支援系	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援
	施設系	施設居住系	施設系	介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	介護老人福祉施設
				介護老人福祉施設入居者生活介護	地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護	地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
				介護老人保健施設	介護老人保健施設（在宅強化型）	介護老人保健施設（超強化型）
						介護老人保健施設（在宅強化型）
					介護老人保健施設（基本型）	介護老人保健施設（加算型）
						介護老人保健施設（基本型）
					介護老人保健施設（その他）	介護老人保健施設（その他）
				介護医療院	介護療養型医療施設	介護療養型医療施設
					介護医療院	介護医療院（I 型）
						介護医療院（II 型）
						介護医療院（特別）

※特定福祉用具販売及び住宅改修は、いわゆる償還払いのサービスであり、国民健康保険団体連合会に事務委託を行っている保険者のデータに限られ、参照範囲が異なることから　当該集計には含めていない。また、介護療養型医療施設は 2024 年（令和 6 年）3 月 31 日をもって廃止された。

厚生労働科学研究費補助金〈長寿科学政策研究〉「2040 年を見据えた地域特性に応じた介護サービス提供体制の最適化と科学的介護の推進に関する調査研究」（研究代表者：陣内裕成）

別添3

○介護 SCR におけるサービス区分（介護予防給付）

区分 1	区分 2-1	区分 2-2	区分 2-3	区分 3	区分 4-1	区分 4-2
予防給付系	居宅系	居宅系	訪問系	介護予防訪問入浴介護	介護予防訪問入浴介護（看護職員＋介護職員）	介護予防訪問入浴介護（全身浴・看護職員＋介護職員）
						介護予防訪問入浴介護（部分浴・看護職員＋介護職員）
					介護予防訪問入浴介護（介護職員）	介護予防訪問入浴介護（全身浴・介護職員）
						介護予防訪問入浴介護（部分浴・介護職員）
				介護予防訪問看護	介護予防訪問看護（保健師・看護師）	介護予防訪問看護（指定訪問看護ステーション、保健師・看護師）
						介護予防訪問看護（病院・診療所、保健師・看護師）
					介護予防訪問看護（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）	介護予防訪問看護（指定訪問看護ステーション、理学・作業・言語聴覚士）
				介護予防訪問リハビリテーション	介護予防訪問リハビリテーション（病院・診療所）	介護予防訪問リハビリテーション（病院・診療所）
					介護予防訪問リハビリテーション（介護老人保健施設・介護医療院）	介護予防訪問リハビリテーション（介護老人保健施設）
						介護予防訪問リハビリテーション（介護医療院）
				介護予防居宅療養管理指導	介護予防居宅療養管理指導（医師）	介護予防居宅療養管理指導（医師）
					介護予防居宅療養管理指導（歯科医師）	介護予防居宅療養管理指導（歯科医師）
					介護予防居宅療養管理指導（薬剤師）	介護予防居宅療養管理指導（薬剤師）
					介護予防居宅療養管理指導（管理栄養士）	介護予防居宅療養管理指導（管理栄養士）
					介護予防居宅療養管理指導（歯科衛生士等）	介護予防居宅療養管理指導（歯科衛生士等）
			通所系	介護予防通所介護	介護予防認知症対応型通所介護	介護予防認知症対応型通所介護（単独型）
						介護予防認知症対応型通所介護（併設型）
						介護予防認知症対応型通所介護（共用型）
				介護予防通所リハビリテーション	介護予防通所リハビリテーション（介護老人保健施設・介護医療院）	介護予防通所リハビリテーション（介護老人保健施設）
						介護予防通所リハビリテーション（介護医療院）
					介護予防通所リハビリテーション（病院・診療所）	介護予防通所リハビリテーション（病院・診療所）
			短期入所系	介護予防短期入所生活介護	介護予防短期入所生活介護	介護予防短期入所生活介護（単独型）
						介護予防短期入所生活介護（併設型）
				介護予防短期入所療養介護	介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設・介護医療院）	介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設）
						介護予防短期入所療養介護（介護医療院）
					介護予防短期入所療養介護（療養病床を有する病院・診療所）	介護予防短期入所療養介護（療養病床を有する病院）
						介護予防短期入所療養介護（診療所）
			居住系	介護予防特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護
				介護予防認知症対応型共同生活介護	介護予防認知症対応型共同生活介護	介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）
						介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用）
			多機能系	介護予防小規模多機能型居宅介護	介護予防小規模多機能型居宅介護	介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用以外）
						介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用）
			住環境整備系	介護予防福祉用具貸与	介護予防福祉用具貸与	介護予防福祉用具貸与（用具別※詳細は別添４参照）
			支援系	居宅介護予防支援	居宅介護予防支援	居宅介護予防支援

※　介護予防特定福祉用具販売及び介護予防住宅改修は、いわゆる償還払いのサービスであり、国民健康保険団体連合会に事務委託を行っている保険者のデータに限られ、参照範囲が異なることから当該集計には含めていない。

厚生労働科学研究費補助金〈長寿科学政策研究〉「2040 年を見据えた地域特性に応じた介護サービス提供体制の最適化と科学的介護の推進に関する調査研究」（研究代表者：陣内裕成）

別添4

○サービス区分（区分 4-2）福祉用具貸与・用具別一覧

介護給付
福祉用具貸与（車いす貸与）
福祉用具貸与（車いす付属品貸与）
福祉用具貸与（特殊寝台貸与）
福祉用具貸与（特殊寝台付属品貸与）
福祉用具貸与（床ずれ防止用具貸与）
福祉用具貸与（体位変換器貸与）
福祉用具貸与（手すり貸与）
福祉用具貸与（スロープ貸与）
福祉用具貸与（歩行器貸与）
福祉用具貸与（歩行補助つえ貸与）
福祉用具貸与（徘徊感知機器貸与）
福祉用具貸与（移動用リフト貸与）
福祉用具貸与（自動排泄処理装置貸与）

介護予防給付
介護予防福祉用具貸与（予防車いす貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防車いす付属品貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防特殊寝台貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防特殊寝台付属品貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防床ずれ防止用具貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防体位変換器貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防手すり貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防スロープ貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防歩行器貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防歩行補助つえ貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防徘徊感知機器貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防移動用リフト貸与）
介護予防福祉用具貸与（予防自動排泄処理装置貸与）

厚生労働科学研究費補助金〈長寿科学政策研究〉「2040 年を見据えた地域特性に応じた介護サービス提供体制の最適化と科学的介護の推進に関する調査研究」（研究代表者：陣内裕成）